

Искусственный мочевого сфинктер (AUS)

WARWIKI

Информация для пациента · Что ожидать перед операцией по установке AUS

Искусственный мочевой сфинктер (AUS) — небольшое устройство, полностью скрытое под кожей, которое восстанавливает контроль над мочевым пузырём при недержании мочи — чаще всего после операции на простате. Вы управляете им сами с помощью помпы, спрятанной в мошонке. Эта памятка объясняет, как он работает, как подготовиться и чего ожидать.

Об этой операции

Выделение мочи при физической нагрузке, кашле или подъёме тяжестей называется **стрессовым недержанием мочи (SUI)** и нередко возникает после операции на простате. AUS устраняет его с помощью трёх соединённых частей, полностью скрытых под кожей:

- Мягкая **манжета** вокруг уретры (мочеиспускательного канала), которая мягко сдавливает её, удерживая мочу
- **Помпа** в мошонке, которую вы нажимаете для мочеиспускания
- Небольшой **баллон** в нижней части живота, регулирующий давление

Как им пользоваться: в обычном состоянии манжета сжата и удерживает мочу. Когда нужно помочиться, несколько раз сожмите и отпустите помпу — манжета откроется. Через несколько минут она автоматически закроется снова.

Это безопасно?

AUS — признанный стандарт лечения этого типа недержания, и большинство мужчин достигают хорошего контроля. Как при любом имплантате, существует риск — главным образом инфекции или износа устройства или уретры с течением времени, что может потребовать повторного вмешательства. Ваша команда снижает риск инфекции с помощью антибиотиков, стерильной техники и предварительного лечения любой инфекции мочевыводящих путей.

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание (SUI)

Выделение мочи при нагрузке, кашле или подъёме тяжестей.

Уретра

Трубка, по которой моча выходит из организма.

Манжета

Часть устройства, сжимающая уретру для удержания мочи.

Помпа

Часть в мошонке, которую нажимают для открытия манжеты и мочеиспускания.

Активация

Включение устройства на приёме примерно через 6 недель после операции, когда всё заживёт.

Деактивация

Выключение устройства (манжета удерживается открытой) — обязательно перед введением катетера.

Общая анестезия

Препараты, которые погружают вас в сон и устраняют боль во время операции.

Цистоскопия

Осмотр уретры и мочевого пузыря камерой, который часто выполняют перед операцией.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинальной анестезией, поэтому во время неё вы ничего не чувствуете. Операция длится около 1–2 часов, и многие пациенты уходят домой в тот же день.

Как подготовиться (до операции)

- Операция под **общей или спинальной анестезией** — соблюдайте все указания хирурга (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты).
- Анализ мочи** проверяет наличие инфекции — инфекцию нужно вылечить до операции; при её выявлении дата может быть перенесена.
- Не курите и не пейте;** примите душ с **антисептическим мылом** (если выдано) и принимайте антибиотики по назначению — профилактика инфекции при имплантате является приоритетом.

Заранее сообщите врачу, если у вас:

- Было **облучение** таза или предыдущие операции на уретре или при недержании
- Есть **сахарный диабет** или ограничения подвижности рук (помпой управляете вы сами)
- Имеется любая инфекция

Что происходит во время операции

- 1 Вы находитесь под анестезией (спите или потеряли чувствительность ниже пояса), вводятся антибиотики.
- 2 Через небольшие разрезы хирург устанавливает **манжету** вокруг уретры, **баллон** в нижней части живота и **помпу** в мошонке — всё под кожей.
- 3 Устройство заполняется и проверяется, затем **оставляется выключенным** для заживления.

После операции

- Ожидайте **отёка и синяков** в области мошонки и промежности 1–2 недели. Носите поддерживающее бельё, прикладывайте лёд и избегайте **нагрузок, натуживания, велосипеда и секса** по указанию хирурга.
- Устройство остаётся ВЫКЛЮЧЕННЫМ около 6 недель** — недержание сохранится (это нормально), пользуйтесь прокладками и **не нажимайте помпу**. Затем на приёме хирург включит устройство и научит вас.
- Всегда сообщайте о наличии AUS** — перед любой катетеризацией его выключают, иначе уретра может быть повреждена.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры, озноб, нарастающее покраснение, боль или выделения из разреза
- Внезапная полная невозможность помочиться
- Мошонка становится очень отёчной, твёрдой или всё более болезненной

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. AUS — скрытое устройство для контроля мочеиспускания: манжета удерживает мочу, а вы нажимаете помпу в мошонке, чтобы помочиться.
2. Устройство остаётся **ВЫКЛЮЧЕННЫМ около 6 недель** (недержание сохранится — это нормально), затем его включают и обучают вас.
3. Профилактика инфекции — главное: вылечите инфекцию заранее, не курите, используйте антисептик и антибиотики по назначению.